Pergunta

Flashcard

# Qual é o índice de massa corporal (IMC) de um paciente com peso de 80 kg e altura de 2 metros?

Cirurgia

# Resposta

Nutrição em Cirurgia

$$IMC = \frac{Peso}{Altura^2} = \frac{80}{4} = 20\ kg/m^2.$$

Pergunta

Flashcard

# Qual é o intervalo de IMC de cada grau de obesidade?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

- Obesidade grau I: entre 30 e 34,9 kg/m²;
- Obesidade grau II: entre 35 e 39,9 kg/m²;
- Obesidade grau III: ≥ 40 kg/m².

Pergunta

Flashcard

# Quais são os valores de IMC dos pacientes com baixo peso, eutrofia ou sobrepeso?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

- Baixo peso: IMC < 18,5 kg/m²;
- Eutrofia: IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m²;
- Sobrepeso: IMC entre 25 e 29,9 kg/m².

Pergunta

Flashcard

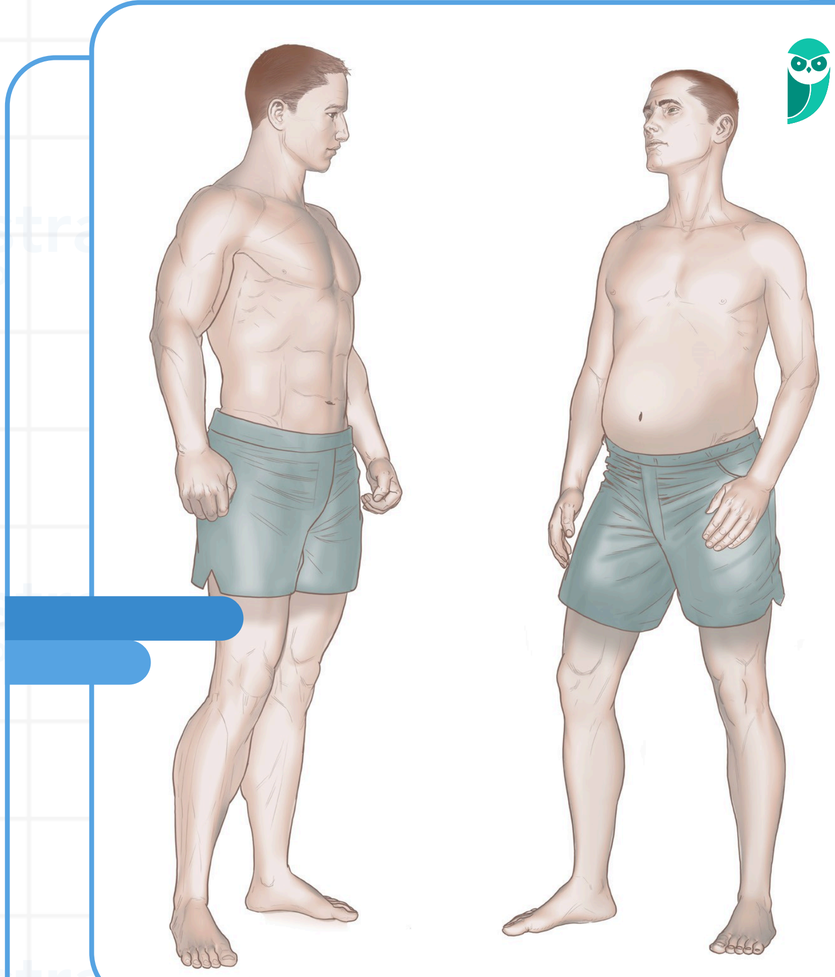
# Por que o IMC, quando usado isoladamente, pode representar equivocadamente o estado nutricional de um indivíduo?

Cirurgia

## Resposta

Nutrição em Cirurgia

# O IMC considera apenas o peso e a altura, sem analisar a composição corporal do paciente. Por exemplo, um homem atleta com 100 kg e 1,80 m de altura tem o mesmo IMC de um homem sedentário com 100 kg e 1,80 m de altura.



Pergunta

Flashcard

# Qual é o nível pré-operatório de albumina considerado fator de risco independente para complicações pós-operatórias graves?

Cirurgia

# Resposta

Nutrição em Cirurgia

## Albumina < 3 g/dL.

Pergunta

Flashcard

# Quais são as 3 proteínas relevantes para avaliar o estado nutricional dos pacientes no período perioperatório?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

# Pré-albumina, transferrina e albumina.

Pergunta

Flashcard

# Qual é a proteína com a menor meia-vida entre aquelas usadas para avaliação nutricional perioperatória?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

# Pré-albumina (meia-vida entre 2-3 dias).

Pergunta

Flashcard

# Qual é o método padrão-ouro para avaliar o gasto energético e as calorias necessárias para um indivíduo?

Cirurgia

# Resposta

Nutrição em Cirurgia

# Calorimetria indireta.

Pergunta

Flashcard

# Quais são as quantidades de quilocalorias e de proteínas estimadas para um paciente adulto que será submetido a uma cirurgia?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

- Calorias: 25 a 35 kcal/kg/dia;
- Proteínas: 1,5 g/kg/dia.

Pergunta

Flashcard

# Cite, pelo menos, 2 critérios para iniciar suporte nutricional perioperatório.

Cirurgia

# Resposta

## Nutrição em Cirurgia

| CRITÉRIOS PARA INICIAR SUPORTE NUTRICIONAL PERIOPERATÓRIO |
| --- |
| Histórico médico prévio: desnutrição grave, doença crônica |
| **Perda involuntária > 10-15% do peso corporal usual dentro de 6 meses ou > 5% dentro de 1 mês** |
| Perda sanguínea esperada > 500 mL durante a cirurgia |
| Peso 20% abaixo do peso corporal ideal ou **IMC < 18,5 kg/m²** |
| Falha em melhorar nas curvas de crescimento e desenvolvimento pediátrico |
| **Albumina sérica < 3,0 g/dL ou transferrina < 200 mg/dL,** na ausência de estado inflamatório, disfunção hepática ou disfunção renal |
| **Previsão de que o paciente não conseguirá cumprir os requisitos calóricos dentro do período perioperatório de 7-10 dias** |
| Doença catabólica (p. ex., queimadura ou trauma significativo, sepse, pancreatite etc.) |

Pergunta

Flashcard

# Qual é a via alimentar preferencial para os pacientes no perioperatório?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

# Via enteral (p. ex.: via oral, cateter nasogástrico, cateter pós-pilórico, gastrostomia ou jejunostomia).

Pergunta

Flashcard

# Cite, pelo menos, 2 contraindicações à nutrição enteral para os pacientes no período perioperatório.

Cirurgia

# Resposta

## Nutrição em Cirurgia

| CONTRAINDICAÇÕES PARA A NUTRIÇÃO ENTERAL |
|---|
| **Vômito intratável, diarreia refratária** |
| **Íleo paralítico** |
| **Fístulas intestinais com alto débito (> 500 mL/24h)** |
| Obstrução gastrointestinal, isquemia |
| **Peritonite difusa** |
| **Choque grave ou instabilidade hemodinâmica** |
| Hemorragia gastrointestinal grave |
| Síndrome de intestino curto (menos de 100 cm de intestino delgado restantes) |
| Má absorção gastrointestinal grave (p. ex., insucesso na nutrição enteral, comprovado pela deterioração progressiva do status nutricional) |
| Incapacidade de obter acesso ao trato gastrointestinal |
| Paciente atingirá as necessidades calóricas esperadas em período < 7 dias |

Pergunta

Flashcard

# Por que a dieta enteral é preferível à dieta parenteral?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

# A carência de alimentos na luz intestinal causa atrofia e redução da barreira mucosa, levando à translocação bacteriana. Por isso, a dieta enteral é preferível.

Pergunta

Flashcard

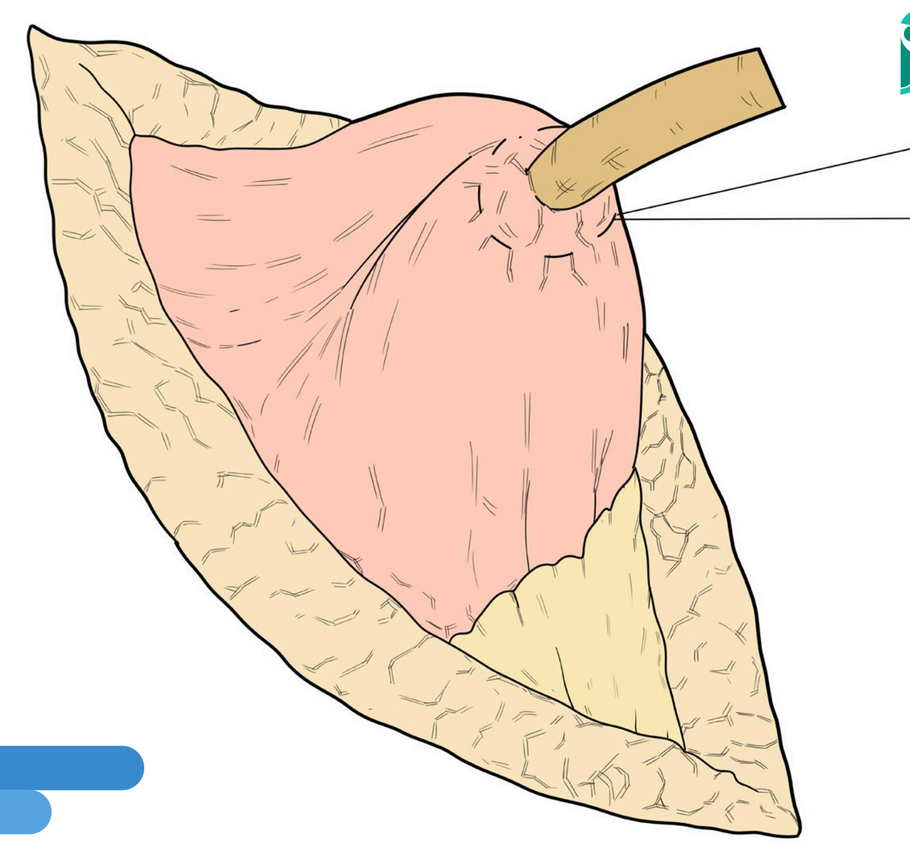
Paciente de 70 anos foi diagnosticado com câncer de esôfago. Não está conseguindo engolir sólidos e nem líquidos, além de ter perdido 20 kg nos últimos 4 meses. Qual é uma possível via de alimentação nesse momento?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

# Gastrostomia confeccionada por via aberta (provavelmente não teria luz suficiente para passagem do endoscópio ou da sonda).



Pergunta

Flashcard

# Cite, pelo menos, 2 indicações de nutrição pós-pilórica.

Cirurgia

## Resposta

Nutrição em Cirurgia

- Risco de broncoaspiração;
- Pacientes com refluxo gastroesofágico ou esofagite graves;
- Paciente apresentando vômitos repetidos;
- Pós-cirurgia ou pós-trauma;
- Gastroparesia.

Pergunta

Flashcard

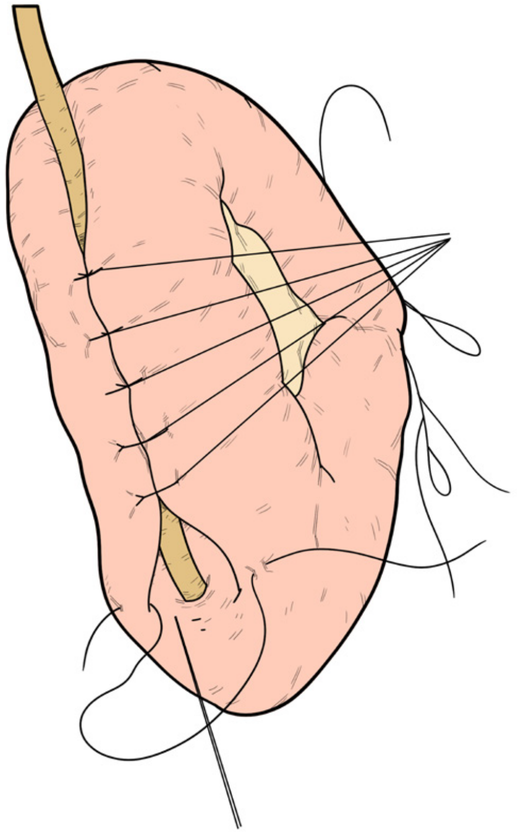
# Que tipo de paciente tem indicação de jejunostomia?

Cirurgia

# Resposta

Nutrição em Cirurgia

## Pacientes com indicação de via alimentar cirúrgica e com contraindicação ao uso do estômago, como os pacientes com câncer gástrico, obstrução pilórica ou gastroparesia importante.



Legenda: jejunostomia à Witzel.

Pergunta

Flashcard

# O que é a dieta imunomoduladora e qual é a sua potencial utilidade para pacientes cirúrgicos?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

# Dieta imunomoduladora é a inclusão de micronutrientes (p. ex.: arginina, ômega-3 e glutamina), cujo potencial benefício é a modulação da resposta imune ao estresse cirúrgico.

## Pergunta

Flashcard

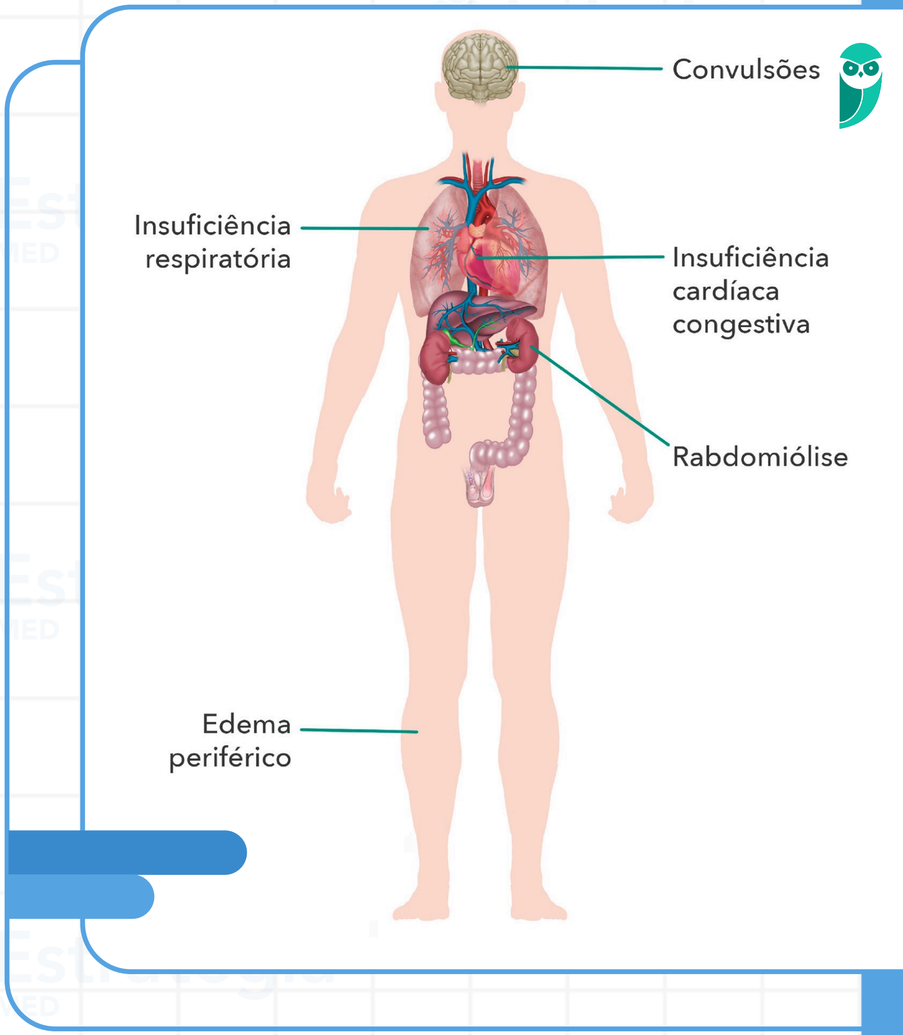
**Diagnóstico provável:** homem de 30 anos realizou uma tentativa de suicídio ao ingerir produtos de limpeza de pH básico. Desenvolveu ulcerações orofaríngeas, rouquidão, disfagia para sólidos e odinofagia. Evoluiu com piora do quadro e desnutrição, com IMC = 14. Foi iniciada nutrição parenteral total.Três dias depois, apresenta dispneia, taquipneia, hipotensão, estertores crepitantes bilateralmente e edema periférico.

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

# Síndrome de realimentação.



Pergunta

Flashcard

# Qual é o tempo de jejum pré-operatório indicado para garantir segurança e benefício ao paciente de acordo com o projeto ACERTO?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

- O jejum não deve ser prolongado;
  - Sólidos: jejum de 6-8h antes da indução anestésica;
  - Líquidos: devem ser ingeridos até 2h antes da anestesia (p. ex.: maltodextrina).

Pergunta

Flashcard

# Quando deve ser começada a realimentação no pós-operatório (projeto ACERTO)?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

Em geral, a realimentação deve ser precoce (em até 24h após a cirurgia). P. ex.: pacientes submetidos à videocolecistectomia ou a herniorrafiaspodem receber dieta e hidratação oral imediatamente.

Pergunta

Flashcard

# Quando o paciente deve iniciar a deambulação no período pós-operatório?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

Se possível, o paciente deve ser estimulado à deambulação precoce (2h fora do leito no dia da operação e 6h nos dias subsequentes).

Pergunta

Flashcard

# Quando há indicação de preparo do cólon nas cirurgias?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

# O preparo colônico não deve ser indicado de rotina. Deve ser indicado nas ressecções colorretais baixas (p. ex.: amputação do reto).

Pergunta

Flashcard

# Há benefício na utilização de dreno profilático nas cirurgias do trato gastrointestinal?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

# Não há benefício do uso de dreno abdominal de rotina.

Pergunta

Flashcard

# Qual é a indicação de hidratação venosa para os pacientes no perioperatório (projeto ACERTO)?

Cirurgia

Resposta

Nutrição em Cirurgia

Os pacientes não devem receber hidratação venosa de rotina. O uso deve ser apenas quando necessário e deve-se evitar a hiper-hidratação do paciente.